EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 77108
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 09-01-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: TERESA GLADYS SALGADO ORTEGA			RUN	: 6.833.967-7
F.Nac	: 24-09-1949	Edad	: 74 AÑOS, 3 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: MATTA 0430			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 87301904		
Fecha Ingreso	: 2024-01-06	Fecha Egreso	: 09-01-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia Respiratoria aguda global
1.1 EPOC exacerbado, causa infecciosa.
2. ICC cFE conservada, descompensada
2.1 Disfunción diastolica G2 + IM severa
2.2 IAM previos ultimo en 2020.
3. HT pulmonar
4. FA cRVR Corregida, en tto. DOAC
5. Hipotiroidismo
6. Bacteriuria asintomática
7. Obesidad
8. Ulcera Varicosa Extremidad Inferior Izquierda

Procedemientos: Linea arterial / CVC Yugular Derecho

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I27.2-OTRAS HIPERTENSIONES PULMONARES SECUNDARIAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I48.2-FIBRILACION AURICULAR CRONICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. E03.9-HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. E66-OBESIDAD. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenino de 79 años antecedente de EPOC, ICC, HTP, FA en Taco, Hipotiroidismo, Obesa, dependiente , semi-postrada, consulta en Servicio de Urgencia tras presentar exacerbación de patrón habitual de disnea, asociado a tos y edema de extremidades inferiores. Se hospitaliza en Servicio de Medicina con impresión diagnostica de ICC descompensada e infección urinaria, sin embargo el día 06/01/2023 presenta exacerbación de la disnea, taquicardia, FA rVr, evaluada por Residente de Medicina, se administra lanatosido C y luego amiodarona; evoluciona con compromiso de consciencia por lo que se solicita evaluación por Residente UCI. Se indica ingresa a su Unidad, se conecta algunas horas VMNI, tras primera ventana y control de GSA, se decide destete y apoyo con FiO2 NRC. Por PA elevadas se maneja con BIC de Nitroglicerina, asociado a manejo depletivo. Paciente evoluciona favorablemente, por lo que se solicita traslado a UTI el 07/01/2024 para continuar manejo depletivo y ATB empírico. El 08/01/2024 se suspende aporte de O2 suplementario, logrando Sat O2 amb 90-93%.
Paciente con hemodinamia autosostenida, ventilando espontáneamente sin aporte de FiO2 suplementaria, completando tratamiento ATB empírico con Ceftriaxona con parámetros inflamatorios en descenso, función

renal conservada, con leve hiponatremia, metabólicamente estable.
Por buena evolución de paciente, se decide continuar manejo por HODOM para completar tratamiento con Ceftriaxona por 7 dias más Kinesioterapia Respiratoria y Motora.

PLAN DE MANEJO:

HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen liviano hiposódico + agua 800 cc /24 hrs
3. Ceftriaxona 2 gr al día ev (5/7)
4. Omeprazol 20 mg 1 comprimido al dia vo
5. Furosemida 40 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
6. Espironolactona 25 mg 1 comprimido al dia vo
7. Dabigatran 150 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
8. Bisoprolol 2.5 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
9. Losartan 50 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
10. Amlodipino 10 mg 1 comprimido al dia vo
11. Levotiroxina 100 ug 1/2 comprimido por la mañana en ayunas vo (30 minutos antes del resto de fármacos)
12. Alopurinol 300 mg 1 comprimido al dia vo
13. Bromuro de Ipratropio 2 puff c/6 hrs c/Aerocamara
14. Salmeterol/Fluticasona (25/250) 2 puff c/12 hrs c/Aerocamara
15. KNT Respiratoria - Motora
16. Continuar curaciones de Ulcera Varicosa EII en APS.

OBSERVACIONES:

Control Post Alta en Sala ERA de su Cesfam
Control Poli TACO (Gestionar hora, ultimo control Agosto/2023)

Control en: 15 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

DANIELA VASQUEZ BAHAMONDEZ
MEDICO TRATANTE
16516335-4

JEFE SERVICIO